

БЕКИТЕМ

Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо жана социалдык
өнүктүрүү министрлигинин алдындагы
Дары каражаттары жана медициналык
буюмдар департаментинин
директорунун орун басары

Мамбеталиева Ч. М.

«02»

июнь

2021-ж.



**ДАРЫ КАРАЖАТЫН МЕДИЦИНАДА КОЛДОНУУ БОЮНЧА
НУСКАМА**

ЦЕЛЕВО

Препараттын соодадагы аталышы: Целево

Эл аралык патенттелбеген аталышы: Левофлоксацин

Дарынын түрү

Жука чел кабык менен капталган таблеткалар.

Курамы

Жука чел кабык менен капталган ар бир таблетка төмөнкүлөрдү камтыйт:

Активдүү зат:

Левофлоксацин гемигидраты

левофлоксацинге туура келет 500 мг

Көмөкчү заттар: жүгөрү крахмалы, натрий бензоаты, магний стеараты, тазартылган тальк, натрий крахмалгликоляты, коллоиддүү суусуз кремний диоксиди, Akoat-512, темир оксидинин кызыл боёгучу.

Сүрөттөмөсү

Бир тарабында экиге бөлүүчү сызыгы менен, эки тарабы томпоюп чыгып турган, сүйрү, ачык-күрөң түстөгү, жука чел кабык менен капталган таблеткалар.

Фармадарылык тобу: Системалуу колдонуу үчүн микробго каршы препараттар. Системалуу колдонуу үчүн бактерияга каршы препараттар. Бактерияга каршы препараттар – хинолондон өндүрүлгөндөр. Фторхинолондор. Левофлоксацин.

АТХ коду: J01MA12.

Фармакологиялык касиеттери

Фармакодинамикасы

Левифлоксацин – фторхинолондор тобундагы кеңири чөйрөдө таасир берүүчү синтетикалык бактерияга каршы препарат, активдүү заттар катары левифлоксацинди камтыйт — офлоксациндин солго айлануучу изомери. Левифлоксацин ДНК-гиразаны бөгөттөйт, ДНК суперспирализациясын жана ажыроолорунун биригүүсүн бузат, ДНК синтезин басаңдатат, цитоплазмада, клетка керегесинде жана бактериялардын мембраналарында терең морфологиялык өзгөрүүлөрдү пайда кылат.

Левифлоксацин *in vitro* сыяктуу эле *in vivo* шарттарында көпчүлүк микроорганизмдердин штаммдарына карата активдүү

Сезгичтүү микроорганизмдер (МПК < 2 мг/л):

Аэробдук грам оң микроорганизмдер: *Corynebacterium diphtheria*, *Enterococcus* spp. (ошондой эле *Enterococcus faecalis*), *Listeria monocytogenes*, *Staphylococcus* spp., коагулазонегативдүү метициллин сезгичтүү - орточо сезгичтүү (анын ичинде *Staphylococcus aureus* метициллин сезгичтүү, *Staphylococcus epidermidis* метициллин сезгичтүү), *Streptococcus* spp. (С жана G топтору), *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus pneumoniae* пенициллинге сезгичтүүлөр/- орточо сезгичтүү/ - резистенттүү, *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus* spp. *viridans* топтору пенициллин сезгичтүү - резистенттүү.

Аэробдук грам терс микроорганизмдер: *Acinetobacter* spp. (анын ичинде *Acinetobacter baumannii*), *Citrobacter freundii*, *Eikenella corrodens*, *Enterobacter* spp. (анын ичинде *Enterobacter aerogenes*, *Enterobacter agglomerans*, *Enterobacter cloacae*), *Escherichia coli*, *Gardnerella vaginalis*, *Haemophilus ducreyi*, *Haemophilus influenzae* ампициллин сезгичтүүлөр - резистенттүү, *Haemophilus parainfluenzae*, *Helicobacter pylori*, *Klebsiella* spp. (анын ичинде *Klebsiella pneumoniae*, *Klebsiella oxytoca*), *Moraxella catarrhalis* (продуцирлөөчү жана бета-лактамазга продуцирлөбөгөн штаммдар), *Morganella morganii*, *Neisseria gonorrhoeae* (анын ичинде пенициллиназга продуцирлөөчү), *Neisseria meningitidis*, *Pasteurella* spp. (анын ичинде *Pasteurella multocida*, *Pasteurella dagmatis*, *Pasteurella canis*), *Proteus mirabilis*, *Proteus vulgaris*, *Providencia* spp. (анын ичинде *Providencia stuartii*, *Providencia rettgeri*), *Pseudomonas* spp. (анын ичинде *Pseudomonas aeruginosa*), *Salmonella* spp., *Serratia* spp. (анын ичинде *Serratia marcescens*).

Анаэробдук микроорганизмдер: *Bacteroides fragilis*, *Bifidobacterium* spp., *Clostridium perfringens*, *Fusobacterium* spp., *Peptostreptococcus*, *Propionibacterium* spp., *Veillonella* spp.

Башка микроорганизмдер: *Bartonella* spp., *Chlamydia pneumoniae*, *Chlamydia psittaci*, *Chlamydia trachomatis*, *Legionella* spp. (анын ичинде *Legionella pneumophila*), *Mycobacterium* spp. (анын ичинде *Mycobacterium leprae*, *Mycobacterium tuberculosis*), *Mycoplasma hominis*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Rickettsia* spp., *Ureaplasma urealyticum*.

Орточо сезгичтүүлөр (МПК > 4 мг/л):

Аэробдук грам оң микроорганизмдер: *Corynebacterium urealyticum*, *Corynebacterium xerosis*, *Enterococcus faecium*, *Staphylococcus epidermidis* метициллин туруктуу, *Staphylococcus haemolyticus* метициллинрезистентные.

Аэробдук грам терс микроорганизмдер: *Burkholderia cepacia*, *Campilobacter jejuni*, *Campilobacter coli*.

Анаэробдук микроорганизмдер: *Bacteroides thetaiotaomicron*, *Bacteroides vulgatus*, *Bacteroides ovatus*, *Prevotella* spp., *Porphyromonas* spp.

Туруктуу (МПК > 8 мг/л):

Аэробдук грам терс микроорганизмдер: *Corynebacterium jeikeium*, *Staphylococcus aureus* метициллин туруктуу, башкалар *Staphylococcus* spp. Коагулазо жагымсыз метициллин туруктуу.

Аэробдук грам терс микроорганизмдер: Alcaligenes xylosoxidans.

Башка микроорганизмдер: Mycobacterium avium.

Фармакокинети́касы

Левифлоксацин пероралдык кабыл алуудан кийин тез жана дээрлик толугу менен сиңирилет. Тамак-ашты кабыл алуу сиңирүүнүн ылдамдыгына жана толуктугуна анча таасир этпейт. Пероралдык кабыл алуудан кийин 500 мг левифлоксациндин биожеткиликтүүлүгү дээрлик 100% ды түзөт. Бир жолку 500 мг левифлоксациндин дозасын кабыл алгандан кийин, эң жогорку концентрациясы 5,2-6,9 мкг / мл, эң жогорку концентрациясына жетүү убактысы 1,3 саат, жарым жартылай бөлүнүп чыгуу мезгили 6-8 саат. Плазманын белоктору менен байланышуу 30-40% түзөт. Ал органдарга жана ткандарга: өпкөгө, бронхиалдык былжырлуу чел кабыкка, какырыкка, заара-жыныс системасынын органдарына, сөөк ткандарына, мээ жүлүн суюктугуна, эрендик безине, полиморфондук ядролук лейкоциттерге, альвеолярдык макрофагдарга жакшы өтөт.

Боордо кичинекей бөлүгү кычкылданат жана / же деацетилденет. Ал организмден түздөн түз бөйрөктөр аркылуу, түйдөкчөлүү чыпкалоо жана түтүкчө секрециясы аркылуу бөлүнүп чыгат. Пероралдык кабыл алуудан кийин, кабыл алынган дозанын болжол менен 87% 48 сааттын ичинде өзгөрүүсүз заара менен, 72 сааттын ичинде 4% дан азы заң менен бөлүнүп чыгат.

Колдонууга көрсөтмө

Оордуктун жеңил жана орто деңгээлдеги инфекциялар менен чондор. Сизгичтүү микроорганизмдер менен пайда болгон инфекциялык жана сезгенүү оорулары:

- ооруканадан сырткары пневмония;
- заара жолдорунун татаал инфекциялары (анын ичинде пиелонефрит);
- тери катмарларынын жана жумшак ткандардын инфекциялары. Бактерияга каршы дары каражаттарды туура колдонуу боюнча расмий көрсөтмөлөрдү карап чыгуу керек. Төмөнкү шарттагы бейтаптар үчүн фторхинолондор камда турган препараттар болушу керек жана альтернативдик дарылоо болбогондо гана колдонуу үчүн сакталышы керек.
- курч синусит;
- заара чыгаруу жолдорунун татаалдашпаган инфекциялары;
- өнөкөт бронхиттин күчөшү;

Каршы көрсөтмө

- жеке көтөрө албастык (анын ичинде оору таржымалында левифлоксацинге же башка хинолондорго жогорку сезимталдык);
- талма;
- хинолондор менен мурунку дарылоодо тарамыштардын жабыркашы;
- өсүү стадиясындагы балдар же өспүрүмдөр (18 жашка чейин) муун кемирчегинин бузулушунан;
- кош бойлуулук;
- эмчек эмизүү мезгили.

Колдонуу жолу жана дозасы

Целево препаратынын дозалары инфекциянын мүнөзү жана оордугу, ошондой эле болжолдонгон козгогучтун сезгичтиги менен аныкталат:

Целево препаратынын таблеткаларын күнүнө бир же эки жолу ичип кабыл алынат. Таблеткаларды тамактын алдында же тамактануунун ортосунда, чайнабай жана жетиштүү

өлчөмдөгү суюктук менен ичүү керек (0,5тан 1 стаканга чейин).

Бөйрөк функциясы нормалдуу (креатинин клиренси > 50 мл/мин.) оорулууларга Целево препаратынын төмөнкү дозалоо режимин сунуш кылса болот:

- оорукана тышындагы пневмония: 500 мг Целево күнүнө 1-2 жолу (тиешелүүлүгүнө жараша 500-1000 мг левофлоксацин) - 7-14 күн;
 - пиелонефритти кошо алганда, заара жолдорунун инфекциялары: 250 же 500 мг Целево күнүнө 1 жолу (тиешелүүлүгүнө жараша 250-500 мг левофлоксацин) - 7-10 күн;
 - өнөкөт бактериялык простатит: күнүнө 1 жолу 500 мг дан Целево (тиешелүүлүгүнө жараша 500 мг левофлоксацин) 28 күн бою;
 - теринин жана жумшак ткандардын инфекциялары: 250 мг Целево күнүнө 1 жолу (тиешелүүлүгүнө жараша 250 мг левофлоксацин) же 500 мг Целево күнүнө 1-2 жолу (тиешелүүлүгүнө жараша 500-1000 мг левофлоксацин) - 7-14 күн;
 - курсак ичиндеги инфекция: 500 мг Целево күнүнө бир жолу (тиешелүүлүгүнө жараша 500 мг левофлоксацин) - 7-14 күн (анаэробдук флорага таасир этүүчү бактерияга каршы препараттар менен айкалыштырып);
 - кургак учуктун дары-дармекке туруктуу түрлөрүн комплекстүү дарылоо: 500 мг Целево күнүнө 1-2 жолу (тиешелүүлүгүнө жараша 500-1000 мг левофлоксацин) - 3 айга чейин.
- Башка антибиотиктерди кабыл алуудай эле, дене табын нормалдагандан кийин же оору козгогучту ишенимдүү жок кылгандан кийин Целево менен дарылоону кеминде 48-78 саатка чейин улантуу сунушталат.

Дарыгердин көрсөтмөсү жок препарат менен дарылоону үзгүлтүккө учуратпоо же эрте токтотпоо керек. Эгерде сиз препаратты ичпей калсаңыз, анда кийинки дозанын убактысы жакындап калганга чейин, таблетканы мүмкүн болушунча эртерээк ичишиңиз керек. Андан кийин Целево препаратын схема боюнча кабыл алууну улантыңыз.

Левофлоксацин негизинен бөйрөк аркылуу бөлүнүп чыгат, андыктан бөйрөк функциясы чектелген бейтаптарды дарылоодо Целевонун дозасын азайтуу талап кылынат:

Креатининдин клиренси	250 мг/24 саат.	500 мг/24 час.	500 мг/12 час.
	биринчи доза: 250 мг	биринчи доза: 500 мг	биринчи доза: 500 мг
50-20 мл/мин.	андан кийин: 125 мг/24 саат.	андан кийин: 250 мг/24 саат.	андан кийин: 250 мг/12 саат.
19-10 мл/мин.	андан кийин: 125 мг/48 саат.	андан кийин: 125 мг/24 саат.	андан кийин: 125 мг/12 саат.
10 мл/мин. (ошондой эле гемодиализ жана УАПД*)	андан кийин: 125 мг/48 саат.	андан кийин: 125 мг/24 саат.	андан кийин: 125 мг/24 саат.

* гемодиализден же узак убакытка амбулатордук перитонеалдык диализден (УАПД) кийин кошумча дозаларды куюу талап кылынбайт.

Боордун иштөө функциясы бузулганда, дозаны атайын тандоо талап кылынбайт, анткени левофлоксацин боордо өтө эле аз өлчөмдө гана зат алмашат.

Кыйыр таасири

Тамак сиңирүү системасы тарабынан: жүрөк айлануу, кусуу, ич өтүү, табиттин жоголушу, ичтин оорушу, псевдомембраналуу энтероколит; "боор" трансаминазалардын активдүүлүгүнүн жогорулоосу, гипербилирубинемия, гепатит, дисбактериоз.

ЖЖС тарабынан: кан басымдын төмөндөшү, кан тамырлардын коллапсы, тахикардия.
Зат алмашуу тарабынан: гипогликемия (табиттин жогорулашы, тердөө күчөп, калтырак).
Нерв системасы тарабынан: баш оору, баш айлануу, алсыроо, уйкусууроо, уйкусуздук, парестезия, тынчсыздануу, коркуу, галлюцинация, башаламандык, депрессия, кыймылдын бузулушу, калтырак.

Сезүү органдары тарабынан: көрүүнүн, угуунун, жыт, даам жана тийүү сезгичтигинин бузулушу.

Таяныч-кыймыл аппараты тарабынан: артралгия, миастения, миалгия, тарамыштын үзүлүшү, тендинит.

Заара бөлүп чыгаруу системасы тарабынан: гиперкреатининемия, интерстициалдык нефрит.

Кан жаратуу органдары тарабынан: эозинофилия, гемолитикалык аз кандуулук, лейкопения, нейтропения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, панцитопения, геморрагиялар.

Аллергиялык реакциялар: жарык сезгичтиги, кычышуу, теринин жана былжырлуу чел кабыкчалардын шишиши, бөрү жатыш, зыяндуу экссудативдик эритема (Стивенс-Джонсон синдрому), уулуу эпидермальдык некролиз (Лайелл синдрому), бронхоспазм, думугуу, анафилактикалык шок, аллергиялык пневмонит, васкулит.

Башкалары: порфириянын күчөшү, рабдомиолиз, туруктуу калтырама, суперинфекциянын өнүгүшү.

*Сөөк-булчуң системасынын жана байланыштыргыч ткандардын оорулары **

*Нерв системасынын оорулары **

Инъекция болгон жердеги бузулуулар жана жалпы бузуулар

*Психикалык бузулуулар **

*Көрүү органы тарабынан бузулуулар **

*Угуу органы жана тең салмактуулук тарабынан бузулуулар **

* Кээ бир учурларда кооптуулуктун факторлорунун бар экендигине карабастан, хинолондорду жана фторхинолондорду кабыл алуу менен өз ара байланыштуу, сезүү органдарында жана адамдын организмнин ар түрдүү, кээде бир нече системасына таасир этүүчү өтө сейрек, узакка созулган, (бир айга же бир жылга созулган), майып болгон, кайтарылгыс, олуттуу жагымсыз реакциялардын өнүгүшү (анын ичинде тенденит, тарамыштардын үзүлүшү, артралгия, аяктагы оору, басуунун бузулушу, парестезия менен байланышкан невропатия, депрессия, алсыздык, эс тутумдун начарлашы, уйку, угуу, көрүү, даам жана жыт сыяктуу жагымсыз реакциялар) жөнүндө маалыматтар алынган.

Дарылык өз ара таасири

Өз кезегинде калтырак басууга жакын церебралдык даярдыкты төмөндөтүүгө жөндөмдүү, хинолондорду жана заттарды чогуу бир убакта кабыл алууда калтырак басууга даярдыктын деңгээлин айкын төмөндөтүү жөнүндө маалыматтар бар. Ошол эле учурда, бул хинолондорду фенбуфен менен, ушул сыяктуу стероиддик эмес сезгенүүгө каршы каражаттар менен, теофиллин менен бир чогуу бир убакытта колдонууга дагы тиешелүү.

Левифлоксациндин таасири сукральфатты бир эле мезгилде колдонуу менен айкын начарлайт. Магний же алюминий камтыган антациддерди (магний жана алюминий гидроокиси), ошондой эле темир туздарын чогуу бир эле учурда колдонууда ушундай болот. Левифлоксацинди ушул каражаттарды кабыл алуудан кеминде 2 саат мурун же 2 сааттан кийин кабыл алуу керек.

Кальций карбонаты менен өз ара таасири аныкталган эмес.

Левифлоксациндин бөлүнүп чыгышы циметидин жана пробенициддин таасири алдында бир аз жайлайт. Бул өз ара таасир дээрлик эч кандай клиникалык мааниге ээ эмес. Бирок

левофлоксациндин түтүкчө бөлүп чыгарылышын тосуп турган пробеницид жана циметидин сыяктуу дары каражаттарды бир эле учурда колдонууда, левофлоксацин менен дарылоону этияттык менен жүргүзүү керек. Бул биринчи кезекте бөйрөк функциясы чектелген бейтаптарга тиешелүү.

Левифлоксацинди К витамининин антагонисттери менен айкалыштырганда, кандын уюган системасына көзөмөл жүргүзүү керек.

Глюкокортикоиддер (гидрокортизон, преднизолон, метилпреднизолон, дексаметазон, бетаметазон ж.б.) тарамыштын үзүлүп кетүү кооптуулугуна алып келет.

Левифлоксацин циклоспориндин жарым жартылай ажыроо мезгилин жогорулатат.

Алкоголь реакциялык жөндөмдүүлүктү жана көңүл буруу концентрация жөндөмдүүлүгүн начарлатуу менен, БНС тарабынан кыйыр натыйжаларды күчөтүшү мүмкүн (баш айлануу же селейип калуу, уйкусуруу, көрүүнүн бузулуулары).

Өзгөчө көрсөтмөлөр

Целево препаратын хинолон же фторхинолон камтыган дары каражаттарды кабыл алуу менен байланыштуу оору таржымалында олуттуу жагымсыз реакциялардын өнүгүүсү бар бейтаптарга колдонуудан алыс болуу керек. Мындай бейтаптарды левифлоксацин менен дарылоону альтернативдүү дарылоо жолдору жок болгондо жана пайда / тобокелдик катышын кылдаттык менен баалоодон кийин гана баштоо керек.

Узак мөөнөттүү, иштен чыгаруучу, мүмкүн болуучу кайтарымыз олуттуу жагымсыз реакциялар:

Препаратты 1000 мг суткалык дозада кабыл алган учурда, жаш курака жана кооптуулуктун коштоп жүрүүчү факторлоруна карабастан, хинолондорду жана фторхинолондорду кабыл алган бейтаптарда, адамдын организмнин (сөөк булчуң, нерв жана психикалык системасына, сезүү органдарына) ар түрдүү, кээде бир нече системасына таасир этүү менен, өтө сейрек, узакка созулган, майып болгон, кайтарылыгы, олуттуу жагымсыз реакциялардын өнүгүшү жөнүндө маалыматтар алынган.

Кандайдыр бир олуттуу жагымсыз реакциялардын алгачкы белгилери жана симптомдору пайда болсо, левифлоксацинди кабыл алууну дароо токтотуп, тезинен дарыгеринизге кайрылыңыз.

Тендинит жана тарамыштын үзүлүшү:

Тендинит жана тарамыштын үзүлүшү (өзгөчө Ахиллов тарамышы), кээде эки тараптуу, хинолон жана фторхинолондор менен дарылоону баштагандан 48 саат өткөндөн кийин пайда болушу мүмкүн, ошондой эле дарылоону токтоткондон кийин бир нече айга созулушу мүмкүн. Улгайган бейтаптарда, бөйрөк алсыздыгы менен бейтаптарда, паренхиматикалык органдарды трансплантациялоо жана кортикостероиддик дарылоо алып жаткан бейтаптарда тендиниттин жана тарамыштын үзүлүп кетүү коркунучу жогорулайт. Кортикостероиддерди жана фторхинолондорду бир эле мезгилде колдонуудан алыс болуш керек.

Тендиниттин алгачкы белгилери пайда болгондо (мисалы, оор сезгенүү, сезгенүү) Целево препаратын кабыл алууну токтотуу керек жана альтернативдүү дарылоону карап көрүшүңүз зарыл. Жабыр тарткан мүчө (лөр) туура дарыланышы керек. Тендинопатиянын белгилери байкалса, кортикостероиддерди колдонууга болбойт.

Перифериялык нейропатия

Хинолондорду жана фторхинолондорду кабыл алуучу бейтаптарда парестезияга, гипостезияга (төмөнкү сезгичтүүлүктөгү), дизестезияга же алсыздыкка алып келген сенсордук же сенсимотордук полиневропатиянын учурлары жөнүндө маалымдалган.

Целево препаратын кабыл алган бейтаптарга, мүмкүн болгон калыбына келтирилгис шарттардын өнүгүшүн алдын алуу үчүн, эгерде оору, ачышуу, сайгылашуу, тилден калуу же алсыздык сыяктуу нейропатиянын симптомдору пайда болсо, дарылоону улантуудан мурун дарыгерге билдирип коюңуз.

Балдардын жана өспүрүмдөрдү дарылоо үчүн атайын муун кемирчегинин бузулуу ыктымалдыгы үчүн Целевону кабыл алууга болбойт. Балдарда башка, анча уулуу эмес препараттарды колдонууга мүмкүн болбогон учурда гана күтүлүп жаткан клиникалык натыйжалуулукту жана кыйыр натыйжалардын потенциалдуу тобокелдигин эске алуу менен, өмүргө коркунуч келтирилген учурда гана колдонулат. 6 айдан жогору жана 50 кг дан көбүрөөк салмактагы балдарда орточо суткалык доза бул учурда 8 мг / кг, эң жогорку көрсөткүч 10 мг / кг түзөт.

Бөйрөк функциясынын коштоп жүрүүчү төмөндөшүнүн жогорку ыктымалдыгына байланыштуу (глюкоза-6-фосфатдегидрогеназанын жетишсиздиги) улгайган курактагы адамдарга препаратты этияттык менен колдонулушу керек.

*Пневмококктордон пайда болгон, өпкөнүн өтө катуу сезгенүүсүндө Целево оптималдуу дарылык натыйжа бербейи мүмкүн. Айрым козгогучтардан (*Pseudomonas aeruginosa*) пайда болгон жана ооруканада жуктурулган инфекциялар айкалыштырылган дарылоону талап кылышы мүмкүн.*

Целево препараты менен дарылануу учурунда, мисалы, инсульт же катуу мертинүү менен шартталган, баш мээнин коштоп жүрүүчү жабыркоосу менен бейтаптарда калтырак басуунун курч кармоосу өнүгүшү мүмкүн. Калтырак басууга даярдык фенбуфенди, ушул сыяктуу стероиддик эмес сезгенүүгө каршы каражаттарды же теofilлинди бир эле учурда чогуу колдонуу менен жогорулашы мүмкүн.

Левифлоксацинди колдонуу менен фотосенсибилизациянын (күндүн күйгөнүнө окшогон реакциялар менен жарыкка жогорку сезгичтиги) таасири абдан сейрек байкалгандыгына карабастан, фотосенсибилизациядан алыс болуу үчүн оорулууларга абдан зарыл болбосо, күндүн же жасалма ультра көгүш нурларынын таасирине кабылуу сунушталбайт (мисалы, бийик тоолуу аймактарда күндүн таасири же солярийге баруу). Псевдомембраналуу колитке шектүүнү болсо, анда препаратты тезинен токтотуу керек жана тийиштүү дарылоону баштоо зарыл. Мындай учурларда ашказан-ичеги моторикасын басаңдаткан дары каражаттарды кабыл алууга болбойт.

Глюкоза-6-фосфатдегидрогеназа жетишсиздиги бар оорулуулар хинолондорго эритроциттерди (гемолиз) жок кылуу менен реакция жасашы мүмкүн. Ушуга байланыштуу мындай бейтаптарды левифлоксацин менен дарылоо өтө этияттык менен жүргүзүлүшү керек.

Кант диабетти менен ооруган бейтаптарга Целево препаратын дайындоодо гипогликемиянын өнүгүү мүмкүнчүлүгүн эске алуу керек, ал "карышкыр" табит, нервдүүлүк, тердөө, калтырак менен көрсөтүлөт.

Целево препаратын кабыл алууну дене табы калыбына келгенден кийин же козгогучту ишенимдүү жок кылгандан кийин кеминде 48-78 саатка чейин улантуу сунушталат. Эгерде препаратты кабыл алууну өткөрүп жиберсе, анда кийинки дозанын убактысы жакындаганга чейин, таблетканы мүмкүн болушунча эртерээк ичүү керек, андан кийин схемага ылайык дарылоону улантыңыз.

Баш айлануу же селейип калуу, уйкусуроо жана көрүүнүн бузулуусу сыяктуу кыйыр натыйжалар сиздин реакциялык жөндөмдүүлүгүңүздү жана көңүл буруу концентрациясын начарлатышы мүмкүн. Бул жөндөмдөр качан өзгөчө мааниге ээ болгон учурларда (мисалы, авто унаа айдоо учурунда, машиналарды жана механизмдерди тейлөөдө, туруксуз эмес абалда

иш аткарууда) белгилүү бир кооптуулукту жаратышы мүмкүн. Бул, өзгөчө, левофлоксацидин алкоголь менен өз ара таасир этүүсү учурларына тиешелүү.

Кош бойлуулук жана бала эмизүү мезгилинде колдонуу

Өсүү мезгилинде клиникалык изилдөөлөрдүн жоктугунан жана хинолондордун муундардын кемирчегине тийгизген зыяндуу таасиринен улам, Целево препаратын кош бойлуулук жана бала эмизүү мезгилинде колдонууга болбойт.

Унаа каражаттарды башкаруу же ишмердүүлүктүн башка кооптуу түрлөрү менен алектенүү жөндөмдүүлүгүнө таасири

Левофлоксацидин баш айлануу же вертиго, уйкусуроо, көрүүнүн бузулуусу сыяктуу кыйыр натыйжалар бейтаптардын авто унаа айдоо жөндөмдүүлүгүн бузушу жана психомотордук реакциялардын ылдамдыгын жана жогорку көңүл бурууну талап кылуучу ишмердиктин башка потенциалдык кооптуу түрлөрү менен алектенүүсүнө тоскоол болушу мүмкүн. Мындай симптомдор пайда болгон учурда бейтаптарга бул ишмердиктин түрлөрүн аткаруудан алыс болуу сунушталат.

Ашыкча доза

Целево препаратынын ашыкча дозасын *симптомдору* борбрдук нерв системасынын деңгээлинде байкалат (акыл эстин чаташуусу, баш айлануу, эс тутумдун бузулушу жана калтырак басуунун курч кармоосу). Мындан тышкары, ашказан-ичеги бузулуулар (мисалы, көңүл айнуу) жана былжырлуу чел кабыктардын жабыркашы белгилениши мүмкүн; QT интервалынын узарышы (дарылыктан ашып кетүүчү дозаларды кабыл алуу менен изилдөөлөрдө көрсөтүлгөн).

Дарылоо мурда болгон симптомдорго ылайыкталышы керек. Препарат гемодиализ жана перитонеалдык диализ аркылуу бөлүнүп чыгат. Атайын антидоту жок.

Чыгаруу формасы

Ар бир блистерде жука чел кабык менен капталган 10 таблетка.

Бир блистер колдонуу боюнча нускамасы менен бирге картон кутуга салынган.

Сактоо шарты:

25°C дан жогору эмес аба табында, кургак, жарыктан корголгон жерде сактоо керек.

Балдар жетпеген жерде сактоо керек.

Жарактуулук мөөнөтү:

2 жыл. Жарактуулук мөөнөтү аяктагандан кийин колдонууга болбойт.

Дарканалардан берүү шарты:

Дарыгердин рецепти боюнча.

Катоо күбөлүгүнүн ээси:

Vegapharm LLP

Unit 18, 53 Norman Road, Greenwich Centre Business Park,
London, England, SE10 9QF, UK (Улуу Британия)

Өндүрүүчү:

Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd.

Plot No. 19, 20 & 21, Sector-6A, IIE, SIDCUL, Ranipur,
Haridwar-249403, Uttarakhand, India (Индия)

**Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүмдүн (товардын) сапаты боюнча
керектөөчүлөрдөн арыз-доолорду кабыл алуучу уюмдун дареги:**

«Aman Pharm» (Аман Фарм) ЖЧК, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Шоорукова көч. 36.

Тел.: (0312) 560466, E-mail: aman.pharm12@gmail.com